PACIENTE
Roberto Carlos Cartes Jiménez

Datos de demostración
Grupo sanguíneo O+ · Ficha DEMO-TS-2025-0506-01

INFORME MÉDICO

Síndrome de túnel carpiano derecho

Evaluación clínica inicial y plan de manejo conservador.

Fecha: 06-05-2025 · Dra. Camila Fuentes · Hospital de Referencia (ejemplo)

Motivo de consulta

Parestesias nocturnas en pulgar, índice y dedo medio de la mano derecha, de aproximadamente tres meses de evolución. Se exacerban con el uso prolongado del computador.

Antecedentes relevantes

- Sin traumatismo previo de muñeca ni cirugía de mano.
- Sin diabetes ni enfermedades inflamatorias conocidas.
- Trabajo con uso intensivo de teclado y mouse.

Hallazgos

- Tinel positivo en el túnel carpiano derecho; Phalen positivo a los 45 segundos.
- Sensibilidad conservada en territorio del mediano; sin atrofia de la eminencia tenar.
- Fuerza de pinza y prensión conservadas y simétricas.
- Movilidad de muñeca completa; sin signos de tenosinovitis aguda.

Diagnóstico e impresión clínica

Diagnóstico de ejemplo
Síndrome de túnel carpiano derecho leve a moderado, de probable origen por sobrecarga. Sin déficit motor ni atrofia.

CÓDIGO CIE-10 G56.0 ESPECIALIDAD Traumatología

Plan y recomendaciones

- Órtesis nocturna en muñeca derecha por 6 semanas.
- Pausas activas de 2 minutos cada 45 minutos frente al computador.
- Estudio de conducción nerviosa para confirmar severidad.
- Ibuprofeno 400 mg con alimentos solo si hay dolor inflamatorio.
- Control en 6 semanas con resultado del estudio.

Signos de alarma
Pérdida de fuerza en pinza, atrofia de la base del pulgar, dolor persistente en reposo o empeoramiento progresivo de los síntomas.

Dra. Camila Fuentes
Traumatología · documento de ejemplo
Documento de ejemplo

DOCUMENTO DE EJEMPLO
SIN VALOR CLÍNICO